医院感染预防与控制

把防控落实到

每一次诊疗接触

手卫生 · 风险防护 · 环境与装置 · 监测改进



标准预防

覆盖所有患者

按传播风险追加措施

接触 · 飞沫 · 空气

在标准预防基础上实施

标准预防覆盖所有患者

不以是否确诊感染为前提，按暴露风险落实措施。

所有患者

每一次诊疗接触

先评估暴露风险

再匹配防护措施

手卫生

识别时机，规范清洁双手

个人防护用品

按预期暴露选择防护用品

呼吸卫生

落实咳嗽礼仪与源头控制

安全注射

一人一针一注射器

单剂量制剂限一位患者使用

设备与环境管理

规范清洁消毒，重点关注高频接触表面

来源： CDC · Standard Precautions / Core Practices · cdc.gov

手卫生的五个时刻

围绕诊疗接触识别时机，把规则转化为动作。

操作前

先清洁双手，再接触或操作

1. 接触患者前
2. 清洁或无菌操作前

暴露或接触后

及时清洁，避免污染继续传播

3. 体液暴露风险后
4. 接触患者后
5. 接触患者周围环境后

手套不能替代手卫生；脱去手套后应立即清洁双手。

多数临床情境优先含醇手消毒剂；双手有可见污物时，用肥皂和水洗手。

来源： WHO · Your 5 Moments for Hand Hygiene； CDC · Core Practices

按传播风险追加防护

从接诊或分诊开始，尽早识别并启动相应措施。

评估疑似或确诊的传播风险

接触预防

- 按需单间安置
- 使用手套及隔离衣
- 优先专用设备
- 共用设备患者间清洁消毒

飞沫预防

- 患者戴口罩进行源头控制
- 工作人员进入房间
- 或空间时佩戴口罩
- 尽量单间安置

空气预防

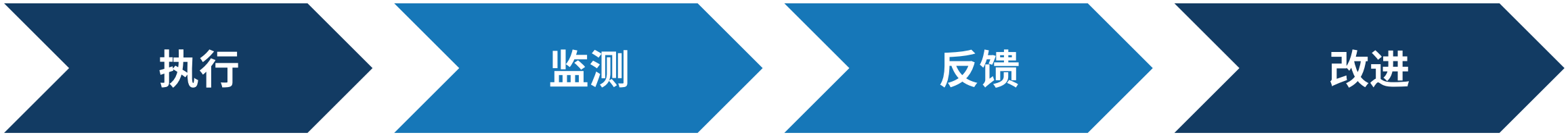
- 使用空气感染隔离病房
- 工作人员使用经
- 适合性检验合格的 N95
- 或更高级别呼吸防护用品

共同基础：上述措施均在标准预防基础上实施。

来源： CDC · Transmission-Based Precautions / Core Practices · cdc.gov

从执行到改进形成闭环

每次落实措施，持续用监测数据推动改进。



执行	监测	反馈	改进
高频接触表面清洁	监测措施依从性	及时、定期反馈	依据数据采取行动
消毒遵循产品说明	关注感染发生情况	覆盖一线与管理层	持续完善防控执行
装置规范置入与维护			

反馈到下一轮执行 · 闭环为教学整理

手卫生到位？　防护匹配风险？　装置仍有必要？

装置每次诊疗评估必要性，在安全条件下尽早移除。

来源： CDC · Core Infection Prevention and Control Practices · cdc.gov